

هيئة الهلال الأحمر السعودي
SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY



التوصيات الأربع ومستهدف سرعة
البدء بالضغطات الصدرية



محاوّر النقاش



• التوصية الأولى



• التوصية الثانية



• مستهدف سرعة البدء بالضغطات الصدرية



• التوصية الثالثة

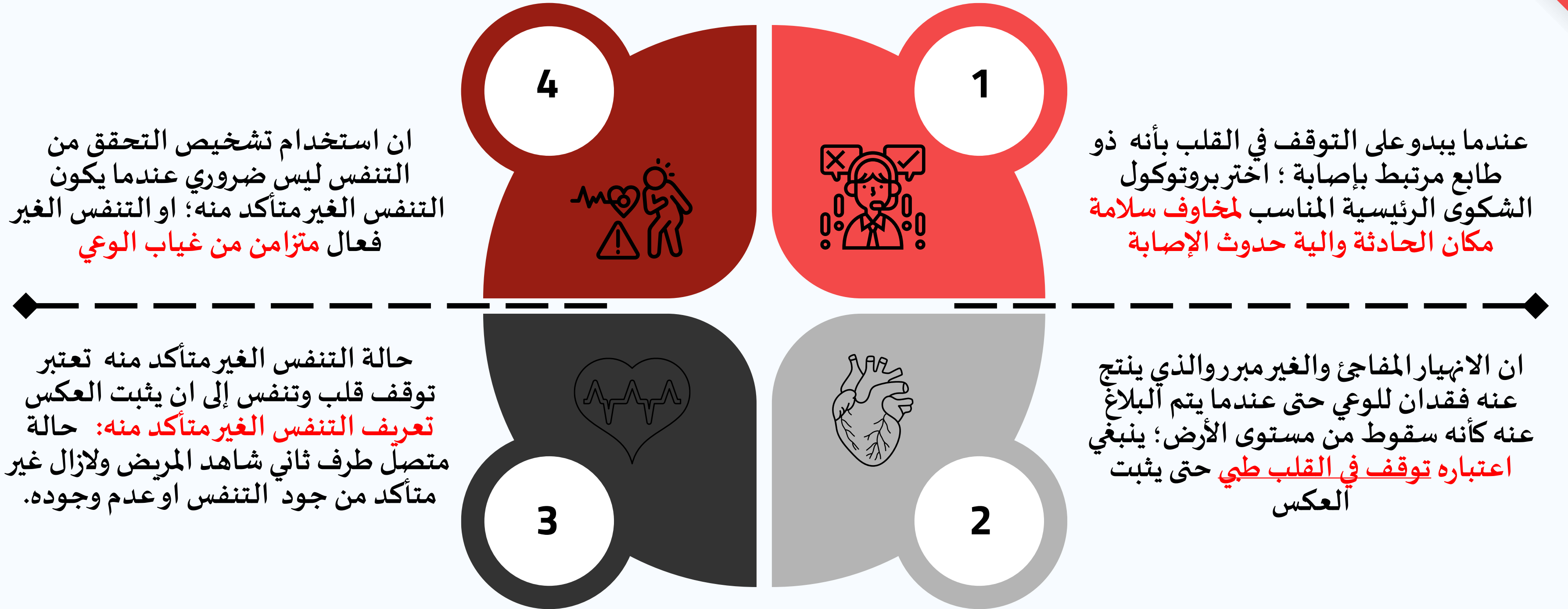


• التوصية الرابعة



هناك العديد من التوصيات المعتمدة من
الأكاديمية الدولية لإرسال الطوارئ، إلا أننا
في هذا النقاش سنناقش أربع منها يمكن
اعتبارها "التوصيات الأربع الذهبية" في
التعامل مع البلاغات وهي:



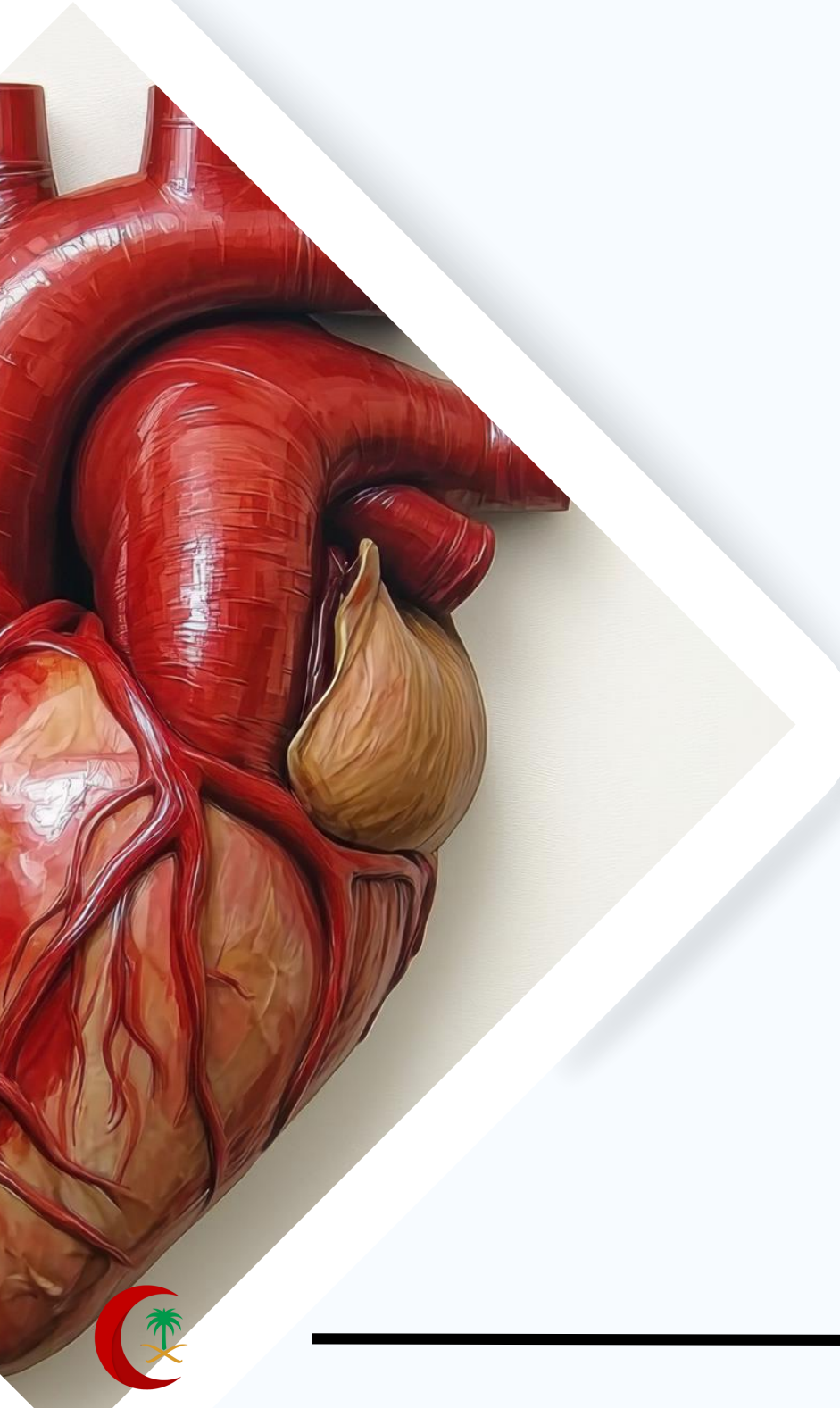




والان سنناقش كل توصية من هذه التوصيات بشكل منفرد



التوصية الاولى



عندما يبدو على التوقف في القلب بأنه ذو طابع مرتبط
بإصابة اختبار بروتوكول الشكوى الرئيسية المناسب
لمخاوف سلامة مكان الحادثة والية حدوث الإصابة.



ماذا يقصد بسلامة مكان الحادثة والية حدوث الإصابة ؟

الاجابة !



إن سلامة مكان الحادثة: هو مبدأ أساسي في برنامج فرز أولوية الإرسال وهو الخطوة الأولى في الاستجابة الطارئة لضمان سلامة الفرق الإسعافية وسلامة طالبي الخدمة الإسعافية

حيث أنه يعنى بتقييم المخاطر في موقع الحادثة بقصد الحفاظ على سلامة الفرق المقدمة للخدمة الإسعافية وسلامة طالبي الخدمة الإسعافية.

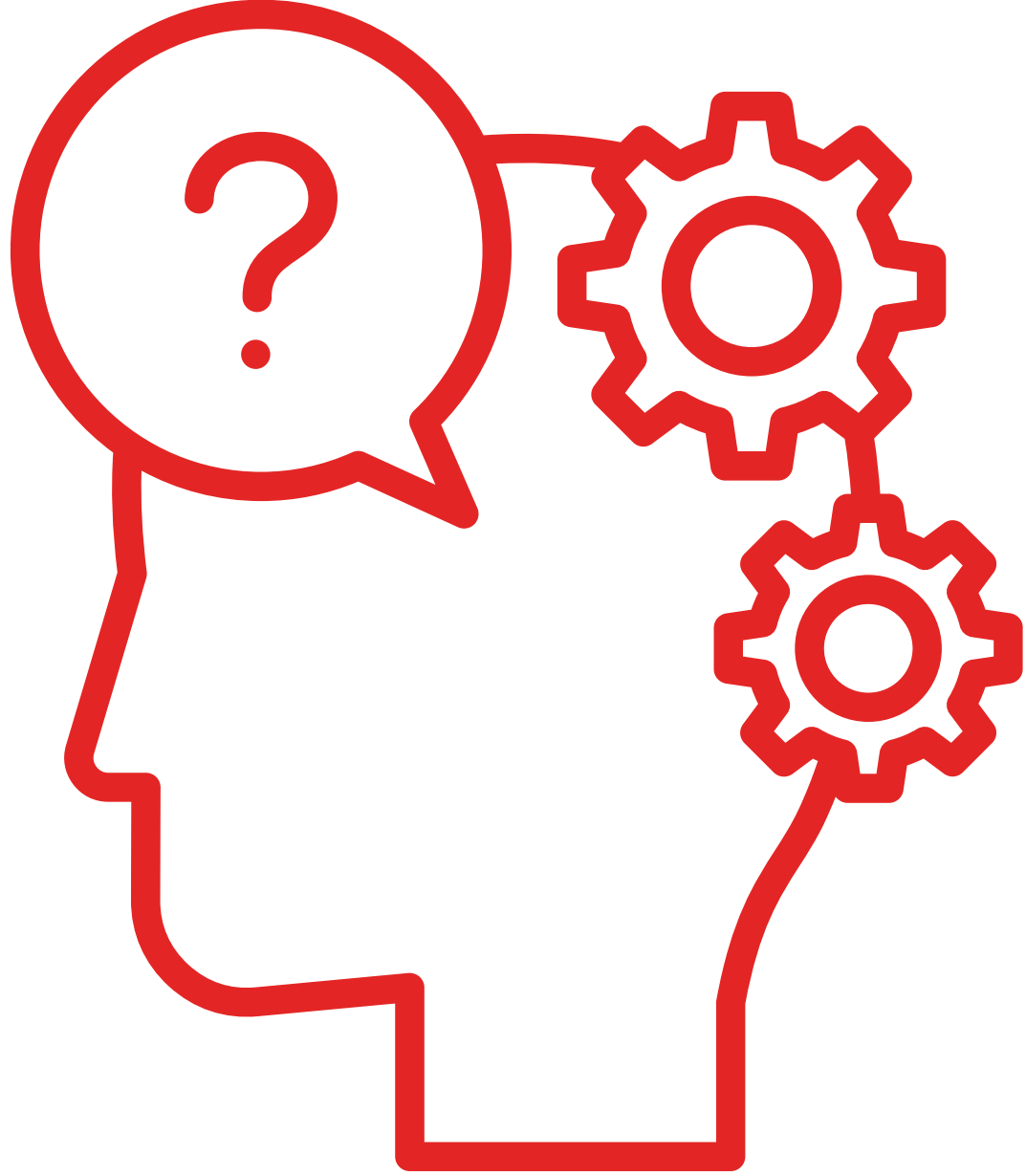


أمثلة شائعة للمخاطر:





- ان هذه المخاطر وغيرها من المخاطر الاخرى يجب علينا التعامل معها بالشكل الأمثل ابتداء من:
- اختيار البروتوكول المناسب لآلية حدوث الاصابة وسلامة مكان الحادثة
 - مروراً بإتباع التسلسل الصحيح لاستجواب هذا البروتوكول
 - انتهاء بإتباع روابط إرسال دعم الحياة المناسبة التي تعنى بالتعامل السريع والمثالي مع موقع الخطر والجريمة حال حدوثها.



ماذا نقصد بآليه حدوث الاصابة ؟

الاجابة !



هي كيفية التي حدوث الاصابة

أمثلة على آليات حدوث الاصابات

صعق كهربائي

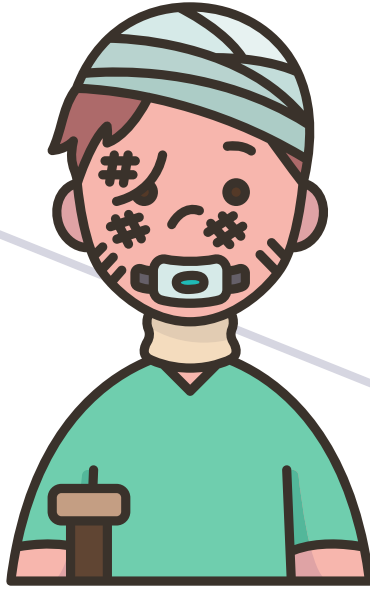
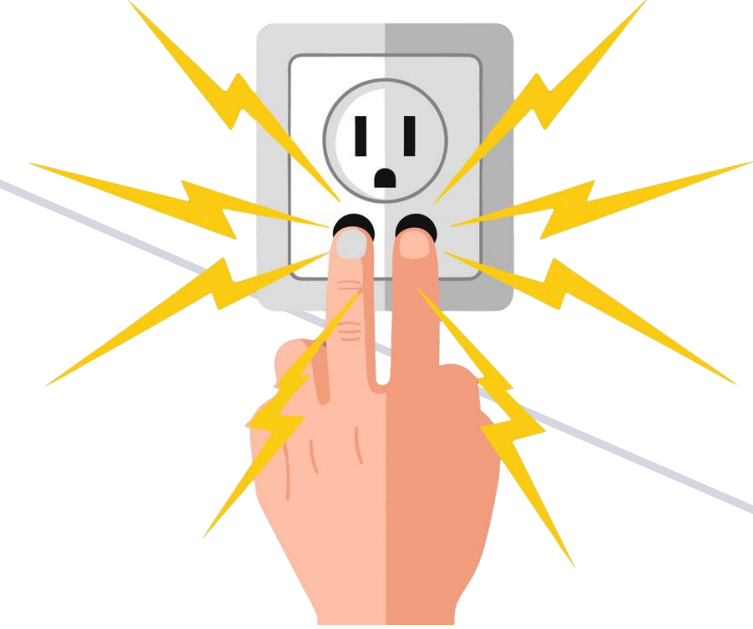
1

سقوط من ارتفاع

2

إعتداء جسدي

3



مثال تطبيقي لما تم مناقشته

السيناريو

الساعة 2:44:15 ص هو زمن مكالمة وارده إلى مركز الترحيل الطبي خلال المناوبة الليلية

المرحل الطبي محمد عبدالله؛ هو من يجيب على هذه المكالمة

وكعادته ملتزماً بتقديم العبارة الافتتاحية الموحدة

الهلال الاحمر؛ محمد عبد الله؛ هل تبلغ عن حالة إسعافية؟



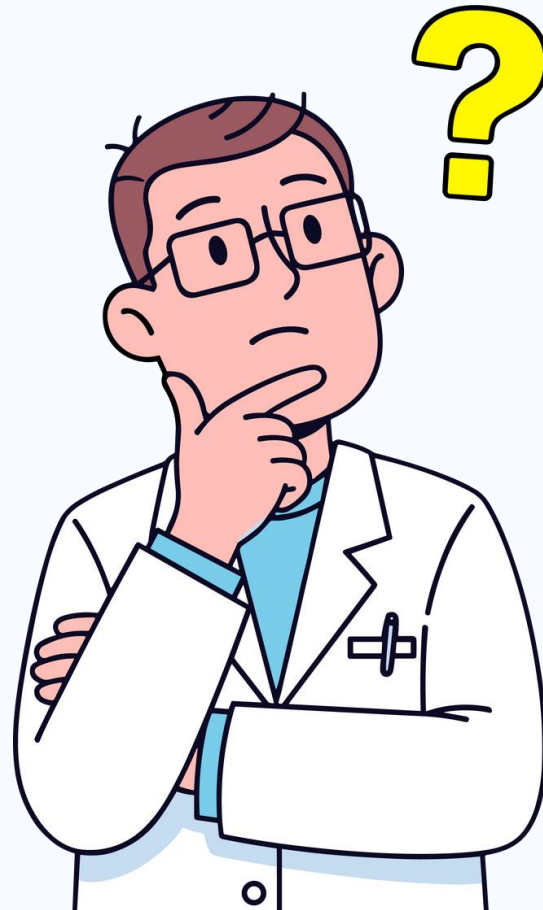
على الطرف الاخر يتحدث متصل بدرجة محتوى انفعالي 4 ويصرخ
نعم نحتاج المساعدة ؛ مصاب في حالة اغماء ولا يتنفس بعد تعرضه لطعنه بالصدر نحتاج المساعدة بشكل عاجل



نقاش ...



بناء على السيناريو المذكور



ما هو بروتوكول الشكوى الرئيسية
الذي يجب على المرحل الطبي محمد
اختياره؟

الاجابة !



البرتوكول

27

27: طعن بسكين / إصابة بطلق ناري / إصابة ناتجة عن اختراق اداة لجسم
الإنسان



تحليل الموقف

الآن وبعد ان قام المرحل محمد باختبار بروتوكول الشكوى الرئيسية المناسب لآلية حدوث الإصابة وسلامة مكان الحادثة (27) هذا ما حدث :

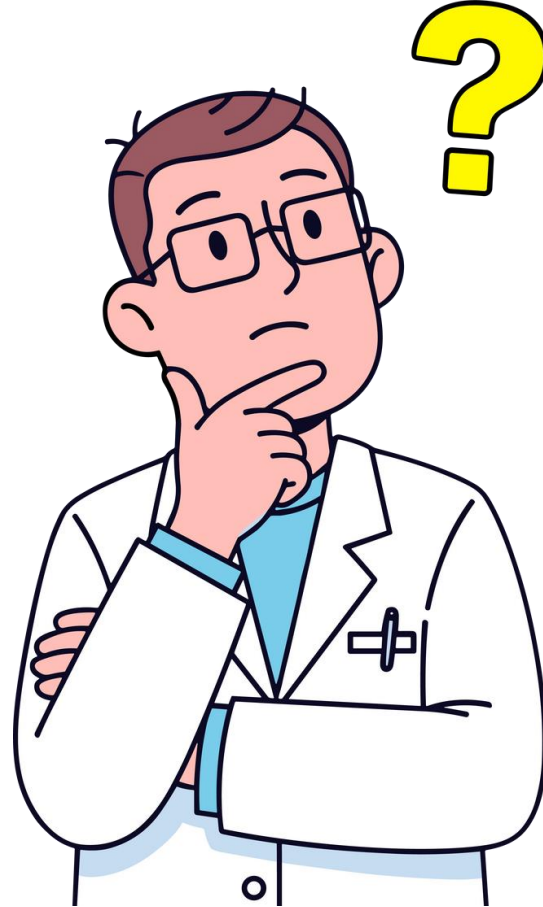
أولاً: قام البرنامج بعد الانتهاء من مدخل الحالة بعرض الأسئلة الرئيسية والتي كان من ضمنها أسئلة السلامة (الأسئلة المدونة باللون الأحمر)

وهي أسئلة تبحث عن مخاطر الموقع بشكل اكبر مثلاً هل المعتدي متواجد أو غادر الموقع.

ثانياً: الفرقة الاسعافية أصبحت على علم ان هذا الموقع هو موقع خطرو جريمة وبه معتدي وسلاح ناري.

ثالثاً : قام البرنامج بعرض رابط ارسال دعم الحياة لتوجيه المتصل بالأجراء الأنسب للحفاظ على سلامته .

رابعاً: تم التنسيق مع الجهات الأمنية بخصوص الحادثة وتأمين الموقع.



التوصية الثانية

ان الانهيار المفاجئ والغير مبرر والذي ينتج عنه فقدان للوعي حتى عندما يتم البلاغ عنه كأنه سقوط من مستوى الأرض ينبغي اعتباره توقف في القلب طبي حتى يثبت العكس .



نحن هنا لانقصد سقوط من ارتفاع بل نتحدث عن انهيار مفاجئ وغير مبرر من على مستوى سطح الأرض .



مستهدف سرعة البدء بالضغطات الصدرية



ان التوصيتان الثالثة والرابعة هما افضل مدخل لمستهدف سرعة البدء بالضغوطات الصدرية وللتذكيرهما:

التوصية الرابعة :

ان استخدام تشخيص التحقق من التنفس ليس ضروري عندما يكون
التنفس الغير متأكد منه؛ او التنفس الغير فعال متزامن من غياب الوعي

التوصية الثالثة :

حالة التنفس الغير متأكد منه تعتبر توقف قلب وتنفس إلى ان يثبت
العكس

يعرف التنفس الغير متأكد منه: على أنه متصل طرف ثاني شاهد المريض
ولازال غير متأكد من جود التنفس او عدم وجوده.

سرعة البدء بالضغطات الصدرية

إن سرعة البدء بعمل الضغوطات الصدرية هو أحد المستهدفات الإستراتيجية للإدارة العامة للتحويل الطبي للعام الحالي 2026م لاشك أن المستهدف مهم جداً وسيكون بإذن الله تعالى عامل رئيسي في انقاذ الارواح حيث انه يهدف إلى تقليص زمن البدء بالضغوطات الصدرية في حالات توقف القلب والتنفس الغير مرتبطة بإصابة الى ٢٠ ثانية كحد اقصى منذ بدأ المكالمة مع طالب الخدمة الإسعافية



سرعة البدء بالضغطات الصدرية



120 ثانية



يفترض ان تكون المدة الزمنية منذ بدء المكالمة إلى يضع المتصل يده على صدر المريض **120** ثانية أو أقل.

اهمية سرعة البدء بالضاغطات الصدرية

02



تحسين الوظائف
العصبية والحفاظ
على وظائف الدماغ

حيث أن سرعة البدء بالضغطات
يحافظ على سرعة واستمرارية
تدفق الدم إلى الدماغ
والأعضاء الحيوية مما يقلل من
تلف الدماغ الدائم

01



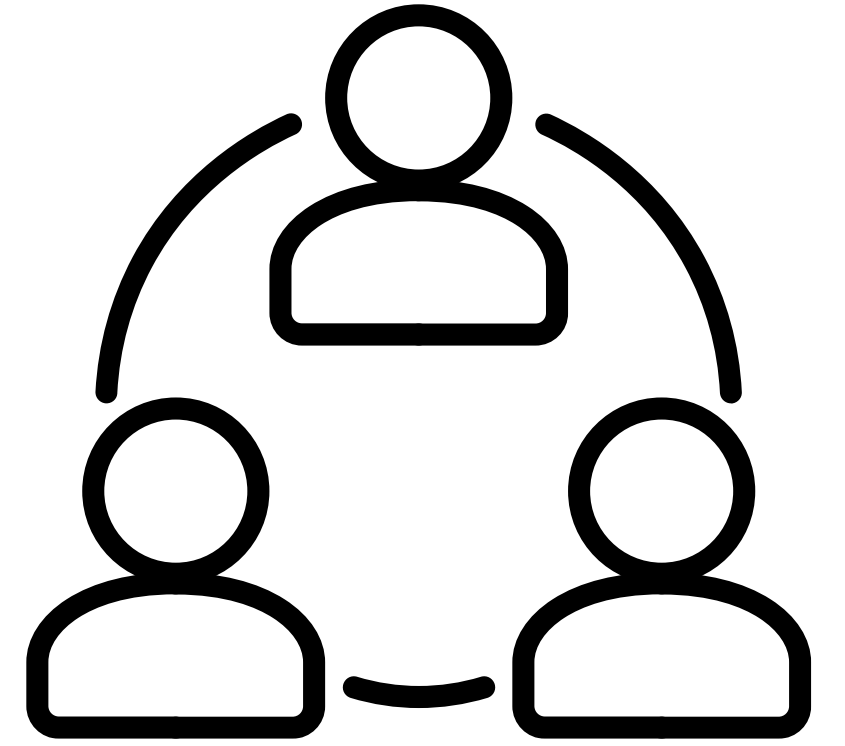
زيادة فرص النجاة

حيث ان سرعة البدء بالضغطات
الصدرية يضاعف من فرص النجاة
بنسبة كبيرة مقارنة بالحالات التي
يكون بها تأخير في زمن البدء
بالضاغطات الصدرية



الآن نود ان نتعرف على ما يتوجب علينا فعله
لتقليص زمن البدء الضغوطات الصدرية إلى أقصى
حد ممكن ؟

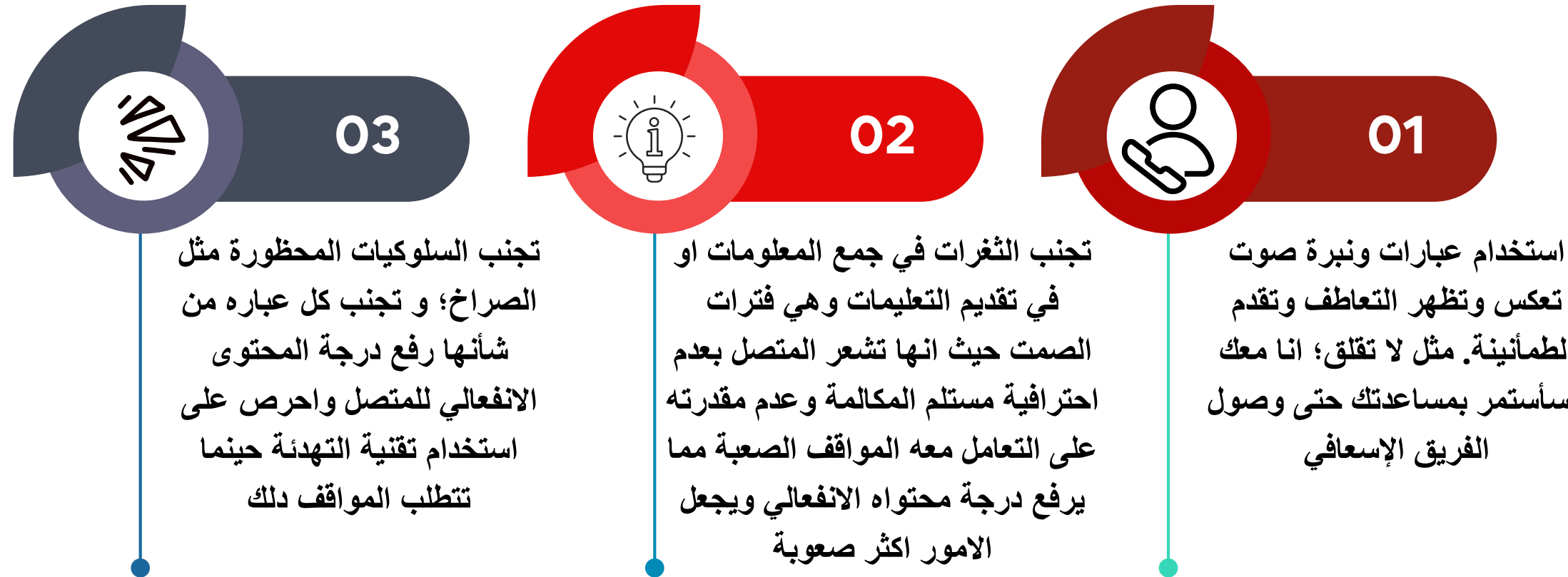
الاجابة !



يعتمد تقليص الزمن المستغرق للبدء بالضغطات الصدرية على ثلاث
ركائز أساسية:

ثانياً: الإدارة الفعالة للمكالمة

لا شك ان الادارة الفعالة للمكالمة ستضاعف نسبة تعاون طالبي الخدمة حيث أنها تخلق مساحة واسعة من الثقة والاطمئنان لديهم وهذا بدوره ينعكس على سرعة تجاوبهم وتفاعلهم في تنفيذ عملية الضغوطات الصدرية و لا شك أن ابرز ملامح الادارة الفعالة للمكالمة يتمثل فيما يلي:



ثالثاً: إتباع أفضل ممارسات الإستجواب

03

تجنب طرح الأسئلة الواضحة مثل :
لوحة تحديد العمر حينما يكون واضحاً
على سبيل المثال عندما يصرح
المتصل مسبقاً بقوله ان المريض
والدي أو والدتي او جدي أو جدتي .

هناك الصدمة الكهربائية

H1 - تحديد العمر

* أنقر على «مفتاح شريط المسافة» إذا كان شخص بالغ (٨ سنوات أو أكبر).

(ليس واضحاً انه شخص بالغ) أحتاج أن أعرف كم عمرهم.

02

تجنب التعليمات
المستقلة مثل تحقق
من النبض

01

تجنب الاسئلة المستقلة وهي
الاسئلة الغير موجودة في
البروتوكول والتي لا تعزز شيئاً
في البروتوكول مثل هل انت
متأكد انه لا يتنفس

تذكر ان هذه الممارسات خاطئة و ستجعلك تستهلك زمن اكبر
قبل البدء بالضغطات الصدرية